Systematische Entwicklungs- und Verlaufsdokumentation in der Integrationshilfe: Ein interdisziplinäres Anforderungsprofil für digitale Vorlagen

Die Arbeit in der Integrationshilfe und Schulbegleitung bewegt sich an den Schnittstellen von Pädagogik, Medizin, Therapie und Sozialrecht. Eine fachlich fundierte Dokumentation dient nicht nur als Nachweis der erbrachten Leistungen gegenüber den Kostenträgern, sondern stellt das zentrale Bindeglied für den interdisziplinären Austausch dar. Um allen beteiligten Akteuren – Eltern, Leistungsträgern wie Jugend- und Sozialämtern, Fachkräften der Ergotherapie und Logopädie sowie der Kinder- und Jugendpsychiatrie oder Neurologie – ein zeitnahes und valides Bild über den Entwicklungsstand und den individuellen Förderbedarf des Kindes zu vermitteln, bedarf es einer strukturierten, digitalisierten Erfassungssystematik.
Der Wechsel von einer zeitaufwendigen handschriftlichen Dokumentation zu einem digitalen Baukastensystem setzt die systematische Erfassung aller pädagogischen und therapeutischen Schnittstellen voraus. Ein digitales Dokumentationswerkzeug muss Alltagssituationen präzise operationalisieren und standardisieren, ohne die Dynamik des Einzelfalls aus dem Blick zu verlieren.

1. Rechtliche Grundlagen, Nomenklatur und interdisziplinäre Anforderungen

Bei der Erstellung einer digitalen Dokumentationsvorlage muss eine klare sprachliche und konzeptionelle Abgrenzung erfolgen. In der Praxis der Eingliederungshilfe hat sich der Begriff des Verlaufsberichts gegenüber dem des Entwicklungsberichts durchgesetzt. Während die Erstellung von Entwicklungsberichten im medizinisch-diagnostischen Sinne primär ärztlichem, psychologischem oder sonderpädagogischem Fachpersonal vorbehalten ist, beschreibt der Verlaufsbericht der Integrationshilfe die konkrete Umsetzung von Teilhabezielen und die Wirksamkeit alltäglicher Assistenzmaßnahmen.
Die gesetzlichen Grundlagen für die Gewährung von Integrationshilfe stützen sich auf das Neunte Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) für Leistungen zur Teilhabe an Bildung sowie auf § 35a des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII) bei Vorliegen oder Drohung einer seelischen Behinderung. Kostenträger verlangen im Rahmen der Hilfeplanung gemäß § 121 SGB IX regelmäßige Nachweise über das Fortbestehen einer Teilhabebeeinträchtigung sowie über den Grad der Zielerreichung.
Einen anerkannten Bezugsrahmen für die behördliche, medizinische und therapeutische Ebene bildet die *International Classification of Functioning, Disability and Health – Children and Youth* (ICF-CY) der Weltgesundheitsorganisation. Die ICF-CY überwindet das klassische biomedizinische Modell, indem sie die funktionale Gesundheit eines Kindes als Wechselwirkung zwischen Körperfunktionen, Aktivitäten, gesellschaftlicher Teilhabe sowie Umwelt- und personbezogenen Kontextfaktoren erfasst. Eine digitale Vorlage, deren Indikatoren an die neun

Lebensbereiche der ICF-CY angelehnt sind, schafft eine gemeinsame Fachsprache für alle Beteiligten.
Der logische Arbeits- und Dokumentationsprozess gliedert sich in mehrere aufeinander aufbauende Phasen. Ausgangspunkt ist die behördliche Bedarfsermittlung im Gesamt- oder Hilfeplan, in dem Teilhabe- und Handlungsziele verbindlich definiert werden. Auf dieser Grundlage erfolgt die alltägliche Assistenz und Begleitung im Unterrichts- und Schulalltag. Die Integrationskraft erfasst die Beobachtungen fortlaufend über die digitale Matrix, woraus automatisierte Verlaufsberichte generiert werden. Diese Berichte fließen wiederum in die interdisziplinäre Abstimmung mit Therapeuten, Ärzten und Eltern ein und dienen den Kostenträgern als Nachweis für die Weiterbewilligung der Maßnahme.
Bei der Ausgestaltung der digitalen Vorlage müssen die datenschutzrechtlichen Vorgaben eingehalten werden. Die Anonymisierung von Mitschülerinnen, Mitschülern und Lehrkräften ist zwingend erforderlich. Ebenso dürfen keine Bewertungen von Lehrleistungen, Schulnoten oder didaktische Urteile in den Bericht einfließen, da die Unterrichtsgestaltung ausschließlich im Kompetenzbereich der Lehrkräfte liegt. Formulierungen müssen stets sachlich, wertschätzend und ressourcenorientiert gehalten sein.

2. Kategoriensystem der Beobachtungspunkte nach Fachbereichen

Um den Förderbedarf transparent darzustellen, müssen die Beobachtungspunkte innerhalb des digitalen Systems logisch strukturiert werden. Die nachfolgenden Kategorien decken die spezifischen Informationsbedürfnisse der unterschiedlichen Fachdisziplinen ab.

Administrative Parameter und Hilfeplandaten

Dieser Bereich erfasst den formalen Rahmen der Hilfeleistung und ermöglicht Kostenträgern die rechtliche und organisatorische Zuordnung der Maßnahme.

- **Stammdaten des Kindes**: Name, Geburtsdatum, Schulart, aktuelle Klassenstufe, Kostenträger und Aktenzeichen.
- **Medizinisch-psychiatrische Diagnostik**: Zuordnung nach ICD-10 (z. B. F84.5 Asperger-Syndrom, F90.0 ADHS, F82 Umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen).
- **Bewilligungsrahmen**: Bewilligter Stundenumfang, Gültigkeitszeitraum des Bescheids, festgelegte Leitziele und Teilhabeziele laut Gesamtplan.
- **Interdisziplinäres Netzwerk**: Ansprechpartner in Schule, Ergotherapie, Logopädie, KJP sowie Sozialpädiatrischen Zentren (SPZ).

Kognitive und Exekutive Funktionen

Für Fachkräfte der Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie der Neurologie sind Beobachtungen der exekutiven Funktionen im Schulalltag essenziell, da klinische Testverfahren die reale Belastungssituation im Klassenzimmer oft nur eingeschränkt abbilden.

- **Aufmerksamkeit und Konzentration**: Spanne der fokussierten Aufmerksamkeit bei Instruktionen, Ablenkbarkeit durch visuelle oder akustische Reize, Ermüdungsverlauf im Unterrichtsleiter.
- **Handlungsplanung und Arbeitsorganisation**: Eigenständiges Bereitlegen von

Arbeitsmaterialien, Einhaltung mehrschrittiger Handlungsanweisungen, Strukturierung des Arbeitsplatzes.
- **Impulskontrolle und Kognitive Flexibilität**: Verhalten bei plötzlichen Strukturbrüchen (z. B. Raumwechsel, Vertretungsstunden), Fähigkeit zum Abwarten, Unterbrechung laufender Handlungen.
- **Reizverarbeitung und Affektsteuerung**: Anzeichen neurofunktionaler Überstimulation (Sensory Overload), Anwendung von Entlastungsstrategien (Stimming, Rückzug), Auslöser emotionaler Dekompensation.

Motorik, Sensorik und Grafomotorik

Ergotherapeutische Interventionen zielen auf die Handlungsfähigkeit im Alltag ab. Die Verlaufsdokumentation erfasst, wie sich therapeutische Fortschritte im Schulalltag manifestieren und wo Fein- oder Grobmotorische Barrieren bestehen.
- **Grobmotorik und Haltungskontrolle**: Rumpfstabilität bei der Stuhlsitzhaltung, Bewegungsdrang, Koordination bei Pausenspielen, Orientierung im Raum.
- **Feinmotorik**: Hand-Hand-Koordination, beidhändiger Werkzeuggebrauch (Schere, Lineal, Zirkel), Pinzettengriff, Kraftdosierung.
- **Grafomotorik und Schreibmotorik**: Stifthaltung (z. B. Dreipunktgriff), Schreibdruck, Einhaltung von Lineaturen, Schreibtempo und grafomotorische Ermüdung.
- **Sensorische Integration**: Taktile Über- oder Unterempfindlichkeit, propriozeptives Feedback (Suchen nach Tiefendruck), vestibuläre Regulation.

Sprachvermögen, Kommunikation und Pragmatik

Logopädische Fachkräfte benötigen konkrete Rückmeldungen über die funktionale Sprachverwendung des Kindes in der sozialen Interaktion.
- **Sprachverständnis**: Erfassen von Arbeitsaufträgen, Verstehen von metaphorischer Sprache, Ironie oder Gruppenerklärungen.
- **Expressive Sprachkompetenz**: Wortschatzabruf, Satzbau, Grammatik und Sprachfluss im Spontansprachgebrauch.
- **Pragmatische Kommunikation**: Blickkontakt, Einhaltung von Sprecherwechseln (Turn-Taking), Einhalten des Themenbezugs, Anpassung der Lautstärke.
- **Unterstützte Kommunikation (UK)**: Nutzung von Talkern, Piktogrammen, Gebärden oder PECS-Karten, Akzeptanz und Initiierung der Hilfsmittel im Schulalltag.

Sozio-Emotionale Entwicklung und Interaktion

Dieser Bereich bildet den Kern von Hilfen nach § 35a SGB VIII und dokumentiert die soziale Teilhabe sowie das Einbinden in die Klassengemeinschaft.
- **Peer-Interaktion und Gruppenintegration**: Kontaktaufnahme zu Mitschülern, Mitspielverhalten in Pausen, Beteiligung an Gruppenarbeiten.
- **Konfliktverhalten und Frustrationstoleranz**: Reaktion auf Misserfolge, Verlieren bei Spielen, Korrekturen durch Lehrkräfte, Frustrationsverarbeitung.
- **Emotionale Regulation und Selbstwertgefühl**: Selbstständigkeit, Adäquatheit der Affekte, Trennungsangst, Schuldistanz, Selbstwirksamkeit.
- **Regeleinhaltung**: Befolgen von Schul- und Klassenregeln sowie Anweisungen des Schulpersonals.

Selbstversorgung und Alltagsautonomie

Das Ausmaß der benötigten Hilfe bei grundlegenden Lebensverrichtungen begründet den quantitativen Stundenbedarf gegenüber dem Sozialamt.

- **Hygiene und Toilettengang**: Ausmaß der Selbstständigkeit bei Toilettenbenutzung, Händewaschen und Einhaltung von Hygienestandards.
- **An- und Auskleiden**: Zurechtfinden beim Garderobenwechsel (z. B. Sportunterricht), Beherrschen von Verschlüssen.
- **Nahrungsaufnahme**: Handhabung von Besteck, Verpflegung in der Mensa, Einhalten von Diätplänen oder medizinischen Vorgaben.
- **Raum- und Zeitorientierung**: Zurechtfinden auf dem Schulgelände, Verstehen von Stundenplänen, Wechsel von Fachräumen.

Umwelt- und Kontextfaktoren

Gemäß der ICF-CY-Systematik entscheidet die Umwelt maßgeblich darüber, ob eine Beeinträchtigung zu einer Behinderung im Schulalltag führt.

- **Förderfaktoren (Facilitators)**: Einsatz von Lärmschutz, visuelle Tagesstrukturen, Nachteilsausgleiche, feste Rückzugsorte, unterstützendes Peer-Umfeld.
- **Barrieren (Barriers)**: Hoher Lärmpegel, Reizüberflutung im Klassenzimmer, unruhige Sitzordnung, unstrukturierte Pausenzeiten, bauliche Hindernisse.

3. Interdisziplinäre Beobachtungs- und Erfassungsmatrix

Die Matrix führt die ICF-CY-Lebensbereiche, konkrete Indikatoren für die digitale Vorlage, die Relevanz für die beteiligten Berufsgruppen sowie den diagnostischen Mehrwert zusammen.

ICF-CY Beobachtungsbereich	Standardisierte Indikatoren & Items für die digitale Vorlage	Relevanz für beteiligte Berufsgruppen	Diagnostischer & Integrationsrelevanter Mehrwert
Kognitive Funktionen & Lernen *(b110–b199 / d110–d199)*	• Fokusdauer bei Einzelarbeit • Ablenkbarkeit durch Umweltreize • Befolgen mehrschrittiger Anweisungen • Wechsel von Arbeitsphasen	• **Neurologie / KJP**: Medikationseinstellung, ADHS-Prozess • **Schule**: Binnendifferenzierung • **Behörde**: Nachweis kognitiver Teilhabebarrieren	Differenzierung zwischen Verarbeitungsstörung und Verweigerung; Ermittlung des Bedarfs an Lernassistenz.
Sensorik, Fein- & Grafomotorik *(b710–b799 / d140–d159)*	• Stifthaltung & Schreibdruck • Grafomotorische Ermüdungszeit • Haltungskontrolle am Sitzplatz • Taktile/auditive	• **Ergotherapie**: Übertrag der Therapie in den Alltag • **Lehrkräfte**: Antrag auf Nachteilsausgleich • **Eltern**: Häusliche Hausaufgabenunterstüt	Erfassung des zeitlichen Verlaufs grafomotorischer Ermüdung; Beleg für die Notwendigkeit technischer Hilfsmittel.

ICF-CY Beobachtungsbereich	Standardisierte Indikatoren & Items für die digitale Vorlage	Relevanz für beteiligte Berufsgruppen	Diagnostischer & Integrationsrelevanter Mehrwert
	Reizverarbeitung	zung	
Sprache & Kommunikation *(b167 / d310–d399)*	• Aktiv- und Passivwortschatz • Verstehen von Instruktionen • Pragmatisches Turn-Taking • Nutzung von UK-Medien / Talkern	• **Logopädie**: Festlegung von Therapiezielen • **Schule**: Sprachförderbedarf • **KJP**: Autismus-Spezifische Interaktion	Beleg über die Wirksamkeit alternativer Kommunikationsmittel; Transparenz bezüglich Sprachbarrieren im Fachunterricht.
Sozio-Emotionale Interaktion *(b122, b152 / d710–d799)*	• Kontaktaufnahme zu Peers • Frustrationstoleranz bei Kritik • Affektregulation bei Überforderung • Einhalten von Sozialregeln	• **Jugendamt (§ 35a)**: Nachweis der Teilhabebeeinträchtigung • **Eltern**: Abgleich Heim-/Schulsetting • **KJP**: Verlauf von Verhaltensstörungen	Identifikation von Auslösern für Aggression oder Rückzug; Evaluation des Unterstützungsbedarfs in Pausen.
Selbstversorgung & Autonomie *(d510–d599 / d200)*	• Selbstständigkeit bei Garderobe/WC • Handhabung von Besteck/Essen • Materialorganisation im Pult • Orientierung auf dem Schulgelände	• **Sozialamt (SGB IX)**: Nachweis des Hilfebedarfs • **Eltern**: Entwicklungsfortschritte im Alltag	Quantifizierung der physischen Assistenz zur Begründung des bewilligten Stundenumfangs der Eingliederungshilfe.
Umweltfaktoren & Kontext *(e110–e599)*	• Lärmpegel im Klassenraum • Wirksamkeit von Reizschutz • Haltung der Lehrkräfte/Klasse • Räumliche/Sächliche Ausstattung	• **Schulträger / Behörde**: Bereitstellung barrierefreier Ausstattung • **Schule**: Anpassung der Rahmenbedingungen	Identifikation institutionalisierter Barrieren, die vor einer Stundenaufstockung durch Schulanpassung zu lösen sind.

4. Methodische Guidelines zur digitalen Vorlagenerstellung

Eine lückenlose und zeitsparende Dokumentation im Berufsalltag erfordert die Einhaltung standardisierter Usability- und Methodikstandards bei der Vorlagenentwicklung.

Implementierung von Assistenzstufen

Qualitative Beobachtungen sollten in der digitalen Vorlage durch eine einheitliche, fünfstufige Skala operationalisiert werden. Dies erlaubt die quantitative Auswertung von Entwicklungsverläufen über längere Zeiträume:

- **Stufe 0 – Vollständig selbstständig**: Das Kind führt die Handlung ohne externe Impulse innerhalb des altersgemäßen Zeitrahmens aus.

- **Stufe 1 – Verbaler Impuls**: Eine einmalige Aufforderung oder Erinnerung reicht zur Handlungsinitiierung aus.
- **Stufe 2 – Visuelle / Strukturierende Unterstützung**: Das Kind benötigt Piktogramme, Checklisten, Ablaufpläne oder Lärmschutz, um die Aufgabe zu bewältigen.
- **Stufe 3 – Physische Teil-Assistenz**: Die Integrationskraft führt Teilhandlungen aus oder gibt direkte Hand-über-Hand-Führung.
- **Stufe 4 – Vollständige Übernahme**: Die Handlung muss aufgrund von Überforderung oder physischer Einschränkung gänzlich von der Assistenzkraft erbracht werden.

Steuerungselemente zur Reduzierung des Schreibaufwands

Um den Erfassungsaufwand im Alltag auf wenige Minuten zu beschränken, sollte die Benutzeroberfläche der digitalen Vorlage drei zentrale Elemente kombinieren:

1. **Standardisierte Dropdown-Menüs**: Vordefinierte Auswahlfelder für wiederkehrende Verhaltensmuster (z. B. *„Reizverarbeitung: sucht selbstständig Reizschutz auf / benötigt Aufforderung / verweigert Reizschutz“*).
2. **Dynamische Textbausteine**: Formulierungshilfen für Mikrosituationen, die bei Bedarf um ein Freitextfeld für Besonderheiten ergänzt werden können.
3. **Aggregierende Tages-Logs**: Kurze tägliche Checkbox-Eingaben, die am Ende des Monats oder Schulhalbjahres automatisch zu einem Verlaufsbericht zusammengefügt werden.

Formulierungsgrundsätze für die rechtssichere Praxis

Beim Ausfüllen der Freitextfelder sind fachliche Standards einzuhalten, um Haftungs- und Datenschutzrisiken zu vermeiden und die Kooperation im interdisziplinären Netzwerk zu sichern:

- **Ressourcenorientierung**: Entwicklungen sind vom Gelungenen her zu beschreiben. Anstelle defizitärer Beschreibungen wie *„Das Kind verweigert das Schreiben“* wird formuliert: *„Das Kind benötigt nach fünf Minuten grafomotorischer Aktivität eine Pause zur Handentlastung, um die Aufgabe fortzuführen“*.
- **Konkrete Verhaltensbeschreibung statt Etikettierung**: Es dürfen keine Vermutungen oder moralischen Wertungen dokumentiert werden. Anstelle von *„Das Kind war heute aggressiv“* gilt: *„Das Kind reagierte auf den unerwarteten Raumwechsel mit lautem Rufen. Durch den Rückzug in den Beruhigungsraum konnte es sich nach zehn Minuten stabilisieren“*.
- **Dokumentation der Assistenzmethode**: Stets ist zu erfassen, welche pädagogische oder strukturierende Maßnahme eingesetzt wurde und wie wirksam diese war (z. B. *„Die mathematische Aufgabenstellung wurde mithilfe von Anschauungsmaterial in zwei Teilabschnitte gliedert“*).

5. Fazit und Handlungsempfehlungen

Eine digitale Dokumentationsvorlage für die Integrationshilfe stellt bei konsequenter Ausrichtung an der **ICF-CY-Systematik** ein hocheffizientes Steuerungsinstrument dar. Die Untergliederung in die Fachbereiche **Exekutive Funktionen** (Psychiatrie/Neurologie), **Grafomotorik und Sensorik** (Ergotherapie), **Pragmatische Kommunikation** (Logopädie), **Sozio-Emotionale**

Integration (Jugendamt/Schule) sowie **Alltagsautonomie** (Sozialamt/Eltern) stellt sicher, dass jede beteiligte Profession mit geringem Leseaufwand die für sie relevanten Indikatoren entnehmen kann.
Für die technische Umsetzung empfiehlt sich die Gestaltung einer datenschutzkonformen Formularanwendung, die Skalierungsabfragen mit Textbausteinen kombiniert. Dies garantiert eine erhebliche Zeitersparnis im Arbeitsalltag, sichert die Einhaltung formaler Vorgaben und stellt eine fundierte Argumentationsgrundlage für die Hilfeplanung und Weiterbewilligung der Eingliederungshilfe bereit.

Quellenangaben

1. Entwicklungsberichte - Förderdiagnostik - sachsen.de, https://www.foerderdiagnostik.bildung.sachsen.de/entwicklungsberichte-4536.html 2. handbuch-integration.pdf - Landkreis Darmstadt-Dieburg, https://www.ladadi.de/umwelt-soziales/familie-chancen/beratung-betreuung/kinderbetreuung/inklusion/handbuch-integration.pdf?cid=29m 3. Arbeitshilfe - LWL-Landesjugendamt Westfalen, https://www.lwl-landesjugendamt.de/media/filer_public/d5/e5/d5e58a32-4081-4f01-8ae9-2991070c6db7/190807zusammenarbeit_von_jugendamtern_und_schulen_im_kontext_von_eingliederungshilfen_gemass__35a_sgb_viii.pdf 4. Entwicklungsverlauf des Schülers: Müssen Schulbegleiter Berichte, https://derschulbegleiterblog.wordpress.com/2025/04/08/entwicklungsverlauf-des-schulers-mussen-schulbegleiter-berichte-schreiben/ 5. Entwicklungsbericht: Aufbau und Nutzen - Sozial-Karriere, https://www.sozial-karriere.de/wiki/entwicklungsbericht/ 6. Verlaufsberichte – die Notwendigkeit der ordentlichen ... - SAB Ruhr, https://sab.ruhr/verlaufsberichte-die-notwendigkeit-der-ordentlichen-dokumentation-in-der-schulbegleitung/ 7. Der professionelle Entwicklungsbericht - TeamLike Schulbegleitung, https://www.teamlike-schulbegleitung.de/der-entwicklungsbericht/ 8. DIE TEILHABEASSISTENZ IN DER SCHULE, https://gemeinsamleben-hessen.de/de/dokumente/Brosch%C3%BCre%20Teilhabeassistenz.pdf 9. MotorikPlus U3 & Ü3 Beobachtungsbogen - Kitalino, https://kitalino.com/funktionen/digitale-beobachtungsboegen/beobachtunsbogen-motorikplus-u3-ue3/ 10. Teilplan Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII überarbeitet, https://www.landkreis-heidenheim.de/site/LRA-HDH-Internet/get/params_E729978715_Dattachment/17353539/Teilplan%20Eingliederungshilfe%20f%C3%BCr%20Kinder%20und%20Jugendliche%20mit%20einer%20%28drohenden%29%20seelischen%20Behinderung%20gem%C3%A4%C3%9F%20%C2%A7%2035a%20SGB%20VIII%20%28PDF%29.pdf 11. Integrierte Teilhabeplanung für Kinder und Jugendliche Thüringen, https://www.tmasgff.de/fileadmin/user_upload/Soziales/Dokumente/Menschen_mit_Behinderungen/ITP/Allgemeines_17_11_22/Manual_ITP_KiJu.pdf 12. Eingliederungshilfe | LaDaDi, https://www.ladadi.de/umwelt-soziales/inklusion/eingliederungshilfe/ 13. Handbuch Förderschwerpunkt emotional-soziale Entwicklung, https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9783779971696_A48811834/preview-9783779971696_A48811834.pdf 14. RAVEK - Befunderhebung von 4-10 Jahren - Ergotherapie.de, https://www.ergotherapie.de/shop/artikel.aspx?bestellnr=15-978-3808008683 15. Motorik & Wahrnehmung – Unterrichtsmaterial im Fach ... - Eduki, https://eduki.com/de/material/2073099/mobiler-sonderpaedagogischer-dienst---motorik-wahrnehmung 16. Renate Zimmers neuer Beobachtungsbogen: MotorikPlus - YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=9xBCwbGcY7U 17. Teilhabe-Hinderung -

Regierungspräsidien Baden-Württemberg,
https://rp.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/RP-Internet/Themenportal/Soziales/Landesarzt/_DocumentLibraries/Fachaustausch/190402_JTSopaed_BTHG_KIJUG_Be.pdf